

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	攝護腺癌 Prostate Cancer				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-K19	N13 翁岱鈺	99 年 01 月 20 日	113 年 12 月 17 日	114 年 10 月 02 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	
	第 3.7 版/10 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	

一、目的

讓護理人員了解攝護腺癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

攝護腺是男性泌尿生殖系統的一個器官，位於膀胱下方，直腸前方，包圍在尿道周圍。如栗子或核桃般大小，隨年齡增加，攝護腺內的腺體增生，體積會愈來愈大，而攝護腺癌則是因為腺體內有惡性細胞增生造成。

（二）症狀

早期的攝護腺癌通常沒有任何症狀。當攝護腺癌腫瘤較大且壓迫到膀胱或尿道時，才會出現頻尿、排尿困難或無法憋尿、尿流量小或間斷、排尿有疼痛感或灼熱感、射精時疼痛、血尿或精液裡帶血、下背部、臀部或大腿上段經常性的疼痛或僵硬等症狀。發生遠端轉移時，最常轉移到骨骼，會引起骨頭疼痛或壓迫神經引起神經痛的症狀，嚴重還會產生病理性骨折。

（三）常見檢查

1. 肛門指檢(Digital Rectal Examination；DRE)。
2. 攝護腺特異抗原(PSA)及攝護腺酸性磷酸(PAP)。
3. 尿液檢體(Urine routine)。

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/10

4. 經直腸超音波檢查(Transrectal ultrasonography；TRUS)。
5. 靜脈腎盂攝影術(IVP)。
6. 膀胱鏡檢(Cystoscopy)。
7. 穿刺切片(Biopsy)。
8. 電腦斷層掃描(Computerized Tomography)。

(四) 常見治療

1. 手術治療

手術治療是早期攝護腺癌最常見治療方式。根除性攝護腺切除手術需將整個攝護腺、貯精囊、輸精管和骨盆腔淋巴結一併切除，出血量多且是目前泌尿外科難度最高的手術之一。手術部位可分為由恥骨後攝護腺切除術，在腹部做切口清除攝護腺及附近的淋巴結；另一為會陰攝護腺切除術，在陰囊及肛門中間做切口移除攝護腺，而附近淋巴結有時需要另外在腹部做切口來清除。切除攝護腺後，膀胱和尿道要重新縫合，所以術後病人會有留置的導尿管，需放置約 7～21 天，等尿道的傷口癒合才可拔除。

2. 非手術治療

非手術性治療可以是局部區域性的，放射線療法即是局部治療，只能殺死治療區域的癌細胞。不適合手術、年紀大或局限的攝護腺癌病人可用放射線治療，用來殺死該區域殘存的癌細胞。對於廣泛性攝護腺癌病人，放射線治療可能用來減輕疼痛或其它問題。放射線可能來自機器之體外放射線或來自植入體內之放射線，即一個小容器內含放射性物質，將其直接置入腫瘤內或附近。某些病人會合併使用這兩種放射線治療。

3. 全身性治療

當區域淋巴轉移或是遠端轉移，局部區域性治療就不適合，通常會考慮用荷爾蒙治療、標靶治療。原理是不讓攝護腺癌細胞得到它生長所需的男性荷爾蒙。當病人接受荷爾蒙治療時，男性荷爾蒙的量會減少。如此降低荷爾蒙的量可以

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/10

影響所有攝護腺癌細胞，即使它們已經轉移到身體其它部位。荷爾蒙治療的方式分為以下：

- (1) 睪丸切除術：是將睪丸切除以除掉主要製造男性荷爾蒙的來源。
- (2) 黃體素促進激素(LHRH)：是用來防止睪丸製造睪固酮。
- (3) 動情素：一種女性荷爾蒙，用來抑制睪丸製造睪固酮。
- (4) 抗雄性素製劑：在睪丸切除術或黃體素促進激素或動情素治療後，身體無法再從睪丸得到睪固酮。但腎上腺仍然會製造少量的男性荷爾蒙。有時病人也要吃抗雄性素製劑，為阻斷任何殘存男性荷爾蒙的作用，藉這種合併性治療達到完全的阻斷雄性激素。一旦荷爾蒙治療沒有效果，會考慮使用化學治療，一般需要在荷爾蒙治療停止後約 1~4 個月才會開始。臨床上常使用的藥物包括有 Mitoxantrone、Taxol、Etoposide 及 Estramustine 等。

(五) 護理問題

1. 焦慮感受／與癌症的診斷及不確定預後有關。
2. 易感染／與侵入醫療程序有關。
3. 疼痛不適／攝護腺癌。
4. 缺乏營養／與疾病或治療造成的食慾不振、噁心、嘔吐有關。

(六) 護理措施

1. 焦慮感受／與癌症的診斷及不確定預後有關
 - (1) 持續評估病人焦慮症狀，如失眠及易怒等程度。
 - (2) 減少刺激，保持寧靜及安全的環境。
 - (3) 鼓勵病人表達所擔心的事及感受。
 - (4) 鼓勵病人及家屬了解疾病及手術的一切狀況。
 - (5) 協助病人及家屬對疾病與手術採取一致性態度，使家屬能成為病人的主要支持者。
 - (6) 鼓勵病人討論其對疾病焦慮的感受。
 - (7) 與病人共同制定其護理計畫。

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/10

(8)評估病人自我照顧及家屬的照顧能力，必要時予以轉介。

2.易感染／與侵入醫療程序有關

- (1)指導病人注意導尿管引流情況，注意尿液排出量，每小時小於 30cc 則需注意有無發炎、鹼性尿液易引起周圍結痂，或是過胖引起狹窄造成尿液滯留。如有以下症狀，如腹脹、觸痛、發燒、尿液排出減少，可能導尿管發生阻塞，應盡快告知醫師。
- (2)衛教病人及家屬導尿管留置期間，隨時觀察導尿管膠帶黏貼有無固定，應注意有無滑脫產生。
- (3)每日飲水至少 2000cc 以預防血尿及感染，進食蔬菜水果防止因便秘導致用力解便，產生血尿阻塞導尿管。

3.疼痛不適／攝護腺癌

- (1)執行詳細的疼痛評估，包括部位、特性、起始／持續時間、頻率、性質、疼痛強度或嚴重度，以及其他相關因素。
- (2)觀察病人不適的非語言暗示，特別是無法有效溝通的病人。
- (3)確保病人有接受適當之止痛照護。
- (4)運用治療性的溝通策略，以了解病人的疼痛經驗，並表達對病人疼痛反應的接受。
- (5)確認病人的疼痛經驗對其生活品質所造成的衝擊，例如：睡眠、食慾、活動、認知、情緒、人際關係、工作表現及角色責任。
- (6)適當地評估病人與疼痛相關之過去經驗，包括慢性疼痛的個人或家族史或疼痛引起之失能。
- (7)與病人及健康照護小組共同評估病人過去曾使用過之有效的疼痛控制措施。
- (8)協助病人及家屬尋求及提供支持。
- (9)提供疼痛相關的資訊，例如：引起疼痛的原因、疼痛持續時間及在某些過程中可能出現的不適感。

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/10

(10)減少或排除可能引發或增強病人疼痛經驗的因子，例如：害怕、疲乏、單調及認知缺失等。當選擇疼痛緩解措施時，考慮病人的參與意願、參與能力、喜好、重要親友對此方法的支持，以及禁忌症等。

(11)選擇疼痛緩解措施時，須考慮疼痛的型態及位置。

(12)鼓勵病人自我監測疼痛的症狀，並適度地予以調整。

(13)配合處方的止痛藥，以提供病人最理想的疼痛緩解。

(14)持續地評估病人的疼痛經驗，以評值疼痛控制措施的成效。

(15)促使病人獲得充足的休息睡眠，以協助疼痛的緩減。

(16)適當地鼓勵病人討論其疼痛經驗。

(17)當使用疼痛緩解方法無效或病人對其疼痛之抱怨不同於往常時，通知醫師做適度的處理。

(18)儘可能地將家屬納入病人疼痛緩解處置計劃中。

(19)定期地監測病人對疼痛處置之滿意度。

4. 缺乏營養／與疾病或治療造成的食慾不振、噁心、嘔吐有關。

(1)告訴病人飲食無特別限制，鼓勵由口進食；如果病人無法由口進食，則報告醫師考慮採用其他方法，如胃灌食。

(2)強調多攝取高蛋白、高熱量飲食，並指導其應如何選擇食物及製作方法。

(3)可採少量多餐、清淡飲食，鼓勵病人保持口腔清潔，以增進舒適，促進食慾。

(4)每天監測病人的營養狀態並計算其熱量。

(5)鼓勵病人進食自己喜愛的食物。

(七) 衛教指導

1. 手術前後護理衛教

(1) 手術前準備

醫師解釋手術效果及可能的合併症，並請病人及家屬填妥手術及麻醉同意書。

若要裝置自控式止痛器者並填具自費同意書，完成手術前各項評估；如心電圖、胸部X光檢查及抽血檢驗等。依醫囑給予腸道準備，給予瀉劑及灌腸，

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/10

並採清流質飲食。

(2)手術後照顧

執行深呼吸及有效咳嗽，以幫助肺部擴張、痰液排出，避免肺炎產生。術後傷口疼痛即可使用自控式止痛器或予止痛劑，避免嚴重疼痛產生。非藥物的方法如深呼吸放鬆法、背部按摩或叩擊、分散注意力、冥想等都可以協助減輕疼痛。視情況儘早下床活動，促進血液循環、腸胃功能的恢復，如：提早排氣、傷口的癒合及避免手術後的合併症產生如肺炎、靜脈栓塞，避免劇烈活動。手術後未排氣前需禁食，排氣後評估腸蠕動，採少量多餐漸進式進食。術後腹部或會陰傷口須觀察傷口變化，定期換藥，一般約術後一星期可拆線。手術後會放置導尿管並牽引止血，以預防出血。由於導尿管的牽引，會有疼痛不適及想解便的感覺，待牽引移除後，這種不適症狀即會改善。拔除導尿管後，可能會發生不等程度的尿失禁現象，可執行骨盆底肌肉收縮運動來改善。

(3)返家後注意事項

出院後請繼續執行骨盆底肌肉收縮運動，以增進尿道括約肌的控制。勿坐浴或熱敷腹部，以免因熱而使血管擴張導致出血。採正常飲食，無特殊禁忌，多食用蔬果預防便秘，避免不必要的灌腸。3個月內勿做劇烈運動，勿提重物及避免騎乘機車、腳踏車及會震動會陰部的運動器材，預防出血。觀察傷口處有紅、腫、熱、痛或發燒、鮮紅血尿、解尿困難症狀，要立刻來醫院處理。返家後有性功能障礙時，可在下次回診時與醫師討論。

(4)飲食衛教

高脂肪、高熱量、低纖維的食物為攝護腺癌的成因。因此健康的飲食：少吃油脂食物、多吃綠葉蔬菜及水果，有助於攝護腺癌的預防。紐約哥倫比亞大學的Lumey教授研究，建議攝護腺癌病人採用低脂肪食物對改善攝護腺癌發生率有所幫助。

(5)放射線治療副作用護理衛教

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/10

接受放射線治療期間可能會變得很疲倦，特別是在治療後幾週。休息是重要的，但醫師通常也會建議病人嘗試體力可以負荷的活動。病人也可能會發生腸道、膀胱及尿道發炎、出血、狹窄、腹瀉、頻尿及解尿不適的副作用。另外，當病人接受體外放射線治療時，在治療區域的皮膚會變紅、乾、壓痛感、搔癢及骨盆區域的毛髮脫落，這可能是暫時性或永久性的，依放射線的劑量而定。放射線治療甚至會造成一些男性陽萎且體外放射線治療造成性無能的機率比體內放射線治療高，因體內放射線治療較不會傷害到控制勃起的神經。

2. 荷爾蒙治療護理衛教

睪丸切除術、黃體素促進激素(LHRH)及動情素常會引起一些副作用，包括性慾降低、陽萎及熱潮紅、骨質疏鬆、代謝症候群、糖尿病及心臟血管疾病等。剛開始使用黃體素促進激素之初期會先促進腫瘤生長，而使病人症狀加劇。這種藥物會漸漸地讓血中睪固酮濃度下降，沒有足夠的睪固酮，腫瘤的生長將會減緩而病人的狀況將會改善。攝護腺癌病人接受動情素或抗雄性素的治療可能會引起噁心、嘔吐或乳房腫脹及觸痛。骨質疏鬆可用鈣片及維生素 D 來補給，甚至每 3~6 個月使用雙磷酸鹽類藥物治療。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/10

- (一) 陳淑妍、黃士滋 (2019)・運用個案管理模式照護一位接受根治性手術之攝護腺癌病人・*新臺北護理期刊*，21(1)，87-96。 [https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6540/NTJN.201903_21\(1\).0008](https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.6540/NTJN.201903_21(1).0008)
- (二) 健康世界編輯部 (2021)・找出攝護腺癌治療新選擇・*健康世界*，(540)，54-54。 <https://www-airitilibrary-com.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/Article/Detail?DocID=16077059-202112-202112220007-202112220007-54-54>
- (三) 李和惠、林麗秋(2021)・內外科護理學・於胡月娟總校閱，生殖系統疾病病人之護理 (六版，219-222 頁)・華杏。
- (四) 劉育志 (2020，04 月 10 日)・不能輕忽！高風險攝護腺癌・照護線上。
<https://www.careonline.com.tw/2020/04/prostate-cancer.html>
- (五) Sekhoacha, M., Riet, K., Motloun, P., Gumenku, L., Adegoke, A., & Mashele, S. (2022). Prostate Cancer Review: Genetics, Diagnosis, Treatment Options, and Alternative Approaches. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 27(17), 5730.
<https://doi.org/10.3390/molecules27175730>

七、附件

(略)

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定。	99 年 01 月 20 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	檢視全文並潤飾用詞。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	刪除藥物治療及輸血治療部份。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31.	3.2	將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 第三項第一、二、三、四、七目參考資料修訂。 2. 第六項第一~六目參考資料內容修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	攝護腺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K19	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	1. 第三項第五、六目護理問題修訂。 2. 第六項將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.7	1. 第三項第四目增加標靶治療。 2. 第六項將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
114.10.02	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	